DETERMINANTS DE LA FAIBLE QUALITE DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS DANS LES CSPS

Présentatrice : Laure TAMINI

Auteurs et coauteurs : **Tamini Laure**, Combary Thérèse, Pilabre Arzouma , Nagalo Kisito, Kaboré Aissata, Kaboret Sonia

Affiliations : Université Joseph KI-ZERBO , Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De GAULLE

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Malnutrition = problème de santé publique mondial; PED++
- OMS (2023) 36M /MAS, 149M/MC chez enfants < 5 ans
- Au BF: problème majeur de SP; PNIN (2024) 9,9% MAS ,19% MC
- Surveillance nutritionnelle : approche opérationnelle ; collecte , analyse données pour décisions politiques adéquates
- Intégrée dans paquet activités minimales des CSPS
- But : rechercher insuffisances afin de réduire taux de malnutrition

Objectif

Etudier les déterminants de la faible qualité de la surveillance nutritionnelle chez les enfants de moins de cinq ans dans les CSPS urbains District Sanitaire de Fada N'Gourma

Matériel et méthode(s)

- Etude transversale à visée descriptive
- Déroulée dans les CSPS urbains du DS de Fada N'Gourma du 15 au 26 avril 2019
- Population d'étude: infirmiers chefs de poste, prestataires de soins et mères d'enfants âgés de moins de cinq ans

Matériel et méthode(s)

- Inclus dans l'étude:
  - Infirmiers chefs de poste consentants
  - Prestataires de soins impliqués dans consultation , activités de SN ayant au moins un an d'ancienneté dans le poste , consentants
  - Mères d'enfant de moins de 5 ans reçues en consultation, consentantes
- Echantillonnage exhaustif : 6 CSPS urbains
- Echantillon : 6 ICP et 24 prestataires de soins ; 60 mères

Matériel et méthode(s)

- Méthode de collecte : l'enquête
- Techniques: observation, entretien et questionnaire
- Outils : fiches de questionnaire ; échelle d'appréciation pour attitudes et pratiques des prestataires ; liste de vérification pour la disponibilité des ressources ; guide d'entretien
- Considérations éthiques : consentement, anonymat, confidentialité
- Analyse données : logiciels Word et Excel 2016

Résultats

❑ Connaissances des agents

Connaissance appréciée	Effectif bonnes réponses (n=24)	Pourcentage
Définition de la SN	6	**25%**
Rythme de consultation	14	**59,3%**
Rythme vitamine A	30	100%
Interprétation des courbes croissance	18	**77,7%**

❑ Conséquence : *mauvaise application de la SN*

Résultats

Attitudes et habileté

Attitudes et habileté	Effectif bonnes Attitudes et habileté (n=24)	Pourcentage
Salue la mère	12	50%
Négociation de RDV	00	**00%**
Exploration mode d'alimentation	7	**33,3%**
Conseils nutritionnels	11	45,8%

Résultats

- Eléments de soutien aux compétences
  - Formations : 70,8%
  - Supervision : 62,5%
- Disponibilité d'infrastructure et de matériel
  - Cuisine : 0%
  - Ustensiles cuisine : 33,3% : *Peu de séances de démonstration*
  - Boites à image : 66,6% *Sensibilisation difficile*
- Vitamine A : 66,6% *Dispensation irrégulière*

Résultats

Mères des enfants

- Distance à parcourir > 10 Km : 38,3% *Non respect des RDV*
- Intérêt préventif de la SN : 44,4% *très insuffisant*
- Fréquentation régulière des centres de santé : 55%
- Application des conseils : 25% *Renforcer la sensibilisation*

Résultats

Difficultés relevées par les mères :

- Insuffisance de moyens financiers
- Insuffisance de connaissance
- Difficultés d'accès aux ingrédients
- Manque de temps

Conclusion

- Faible qualité de la surveillance nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans est multifactorielle
- Mise à niveau constante des compétences des agents de santé, l'équipement des CSPS
- Renforcement sensibilisation des parents pourraient contribuer à une meilleure surveillance nutritionnelle et à la réduction de la malnutrition.

Merci pour votre attention